

天津市第一中心医院

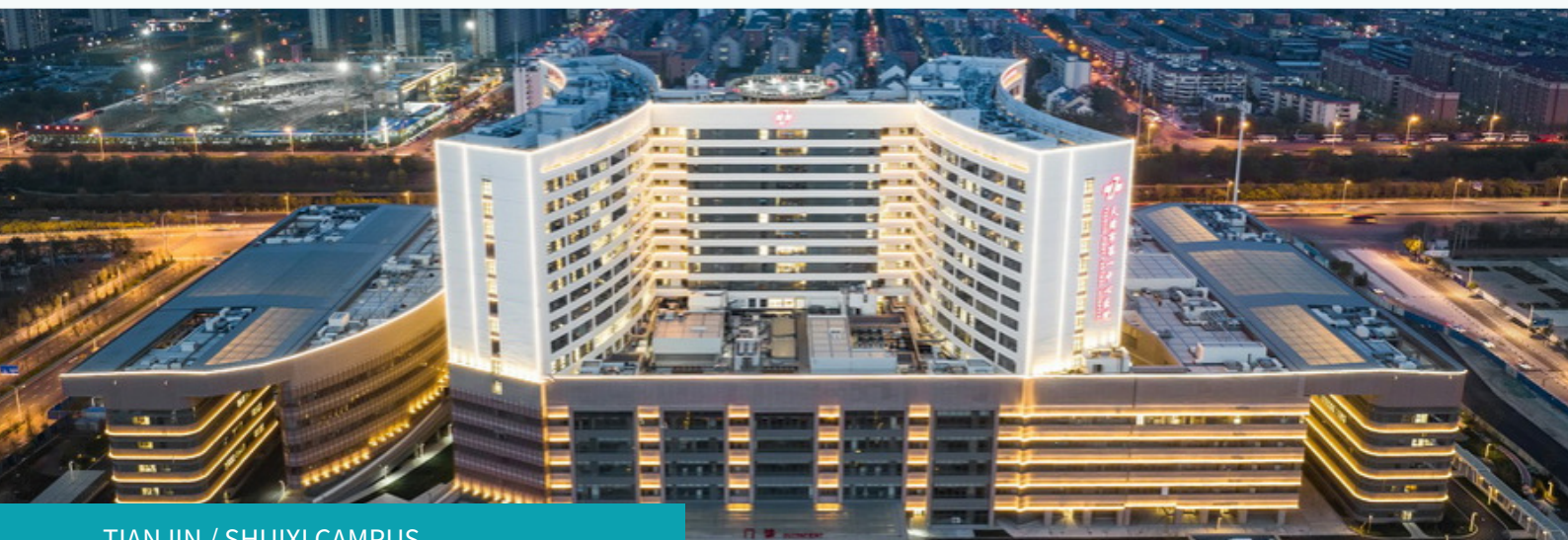
国際診療センター

Tianjin First Central Hospital

International Medical Center

専門の医療を、健康への一步一步に。

Expert Care, Every Step of Your Journey



TIANJIN / SHUOXI CAMPUS

1996年から

国際診療と特需医療の 専門サービス

個別の健康評価

疾病診療と先進的な手術

専用病室と継続的な健康管理



診療場面のイメージ

成人診療と継続的な健康管理

日本語版1.2・2026年9月

01 / センターについて

診療サービスを探す

気になるサービスや疾患を選び、項目をクリックすると該当ページに移動します。

01 センターについて

国際診療センターのご紹介	03
病院の沿革と国際診療の歩み	04
病状に応じた一貫した治療と管理	05

02 重点サービス

オーダーメイドの健康評価	06
胃・大腸内視鏡を中心とした健康評価	07
循環器の健康評価	08
高齢者と複数疾患の総合管理	09
臓器移植に関する診療	10
脾臓細胞移植と移植後の管理	11

04 医療技術と患者サービス

大手術と重症患者への支援	31
高度画像検査と機能評価	32
画像ガイド下処置と精密診断	33
看護・生活支援と言語サービス	34
受診申請から退院後のフォローまで	35
入院環境と日常のケア	36
受診相談と資料の入手	37

03 疾患別の診療

心臓の疾患	12
血管疾患と循環器リスク管理	13
脳・神経系の疾患	14
消化器疾患と内視鏡治療	15
肝胆膵疾患と複雑腹部手術	16
呼吸器・胸部の疾患	17
腎臓・泌尿器の疾患	18
骨・関節・脊椎の疾患	19
内分泌・代謝の疾患	20
リウマチ・免疫性疾患	21
女性の健康と生殖医療	22
眼・耳鼻咽喉・口腔の疾患	23
皮膚疾患と形成・再建	24
乳腺・甲状腺とその他の外科疾患	25
がんの総合診療	26
血液疾患と細胞療法	27
リハビリテーションと疼痛管理	28
中医学による特色ある診療	29
感染症と原因不明の発熱	30

国際診療センターのご紹介



専用病室と常設の医療チームが、治療から長期管理まで継続して支えます。

診療場面のイメージ

1996

国際診療を専門に開始

約90か国

外国人患者の出身国

2F / 16F

外来 / 入院病棟

天津市第一中心医院の国際診療センターは、1996年10月から国際診療および特別医療サービス（特需医療）を専門に提供しています。海外および中国国内の成人患者を対象に、健康評価、疾病の診断・治療、入院治療、リハビリテーション指導、継続的な健康管理を行います。

国際診療の経験

約30年間に、約90か国から1万人以上の外国人患者を受け入れてきました。2008年北京オリンピック天津会場、2025年上海協力機構（SCO）天津サミットでは、外国人向けの医療支援も担当しました。言語を越えた意思疎通、複雑な疾患の管理、文化的背景に配慮したケアは、日常診療の重要な要素です。

治療と疾病管理に直接参加

水西院区に外来と専用入院病室を設け、常設の医師・看護チームが対応します。医師は疾患、治療歴、個別の希望を総合的に評価し、看護師は状態観察、治療支援、生活援助、健康教育を継続します。専門治療と日常の疾病管理を結び、受診前から治療後まで一貫した診療を行います。

成人を対象に、3種類の健康評価、高齢者の総合管理、各領域の疾病診療、移植関連の評価を提供します。現在、小児患者は受け入れていません。

病院の沿革と国際診療の歩み



天津市第一中心医院 水西院区

天津市第一中心医院は1942年に創立され、臓器移植、救急医学、耳鼻咽喉・頭頸部外科を特色とする総合診療体制を発展させてきました。国際診療センターは1996年から国際診療と特需医療を専門に担い、専門治療と継続的な疾病管理を結びつけています。

1942

● 当院の前身である天和医院が創立。

1956

● 複数の医療機関と専門家が合流し、天津市第一中心医院を設立。

1974

● 急性臓器不全（三衰）の救命研究室とICU病室を設置し、救急・集中治療を推進。

1994

● 三級甲等医院に認定。同年、同所性肝移植に成功。

1996

● 国際診療センターが国際診療・特需医療の専門サービスを開始。

1998

● 臓器移植外科を設置し、移植診療体制をさらに発展。

現在 / 継続的な個別診療

現在、センターは水西院区に外来と専用入院病室を設けています。常設チームが健康評価、治療、リハビリ指導、継続管理を行い、病状に応じてチームによる共同管理と医療資源の配置を判断します。

01 / センターについて

病状に応じた一貫した治療と管理



診療場面のイメージ

センターは患者の治療と疾病管理に直接参加します。まず総合評価を行い、病状の複雑さ、治療目標、患者の希望に応じて、チームによる共同管理の必要性を判断します。治療の進行に合わせ、専門職と医療資源の配置を調整します。

01 センターによる総合評価

現在の症状、診断歴、薬剤、アレルギー、手術歴、日常生活機能を確認し、画像・病理・検査資料を見直します。複数の疾患がある場合や診断が未確定の場合は、主要な問題と治療の優先順位を整理し、必要な検査と専門評価を行います。

02 専門科との共同治療

専門的な技術が必要な場合は、該当チームが手術、カテーテル治療、専門治療を担当します。センターは基礎疾患、薬剤確認、栄養、リハビリを管理します。共通の病状情報と治療目標を共有し、薬剤の不整合や重複検査の低減を図ります。

03 必要に応じた治療場所の調整

通常の診療とケアはセンター外来・専用病室で行えます。大手術、重篤な病状、特別な防護が必要な場合は、院内共用ICU、専門監視病棟、専用治療病棟への移動が必要になることがあります。復帰条件を満たせばセンターに戻り、各チームが引き継いで治療を続けます。

04 退院後も継続するフォロー

退院時に薬剤、再検査、リハビリ、注意すべき症状を説明します。短期は電話、長期はメール・WeChatを中心に、病状に応じた頻度でフォローします。再診、検査、居住地の医療機関による支援が必要な場合は、適切な対応を相談します。

02 / 重点サービス

オーダーメイドの健康評価



診療場面のイメージ

病歴、現在の症状、健康上の目標に応じて、センター医師が検査を設計します。慢性疾患や継続服薬がある方は、病状のコントロール、薬剤の適切性、その後の健康管理も合わせて評価します。

01 対象となるニーズ

健康状態を総合的に把握したい方、複数の検査結果をまとめて理解したい方、長期服薬を見直したい方、医師の指導で疾病リスクを評価したい成人が対象です。明らかな症状や異常がある場合は、その臨床上の問題を優先します。

02 検査内容の組み立て

年齢、家族歴、既往歴、生活習慣、既存資料から、身体診察、血液等の検査、超音波、必要な画像検査を選びます。代謝、循環器、消化器、腎臓、骨、女性の健康などに重点を置くことも可能です。連続した複数の評価が必要な場合は、病状に応じて入院での実施を検討します。

03 検査と薬剤管理を一体化

処方薬、市販薬、中医薬、サプリメントを確認し、疾病コントロール、相互作用、肝腎機能を評価します。必要時は医師が治療を調整し、その理由、服用方法、再検査を説明します。健診のために自己判断で常用薬を中止しないでください。

04 継続できる健康計画

重要な異常と優先課題を整理し、結果を説明するとともに食事・運動・生活指導を行います。専門治療が必要な所見は次の診療につなぎ、経過観察が適切な場合は再検査項目、時期、フォロー方法を明確にします。

検査の組み合わせと入院の要否は評価後に決まります。すべての方に同じ検査一式を実施する方式ではありません。

02 / 重点サービス

胃・大腸内視鏡を中心とした健康評価



診療場面のイメージ

胃内視鏡と大腸内視鏡を中心に、消化器症状、ポリープ・腫瘍の既往、家族歴、過去の検査結果を踏まえて、食道・胃・大腸を評価します。適切な病変が見つかった場合は、事前説明と評価のうえで内視鏡治療・病理検査につながります。

01 検査前の評価と準備

心肺疾患、糖尿病、肝腎疾患、出血リスク、麻酔歴と、抗凝固薬・抗血小板薬などを確認します。検査方法に応じて食事、腸管前処置、薬剤調整を説明します。鎮静・麻酔の方法は必要な評価後に決定します。

02 胃・大腸内視鏡が中心

評価に基づき胃内視鏡、大腸内視鏡、または両方を手配します。粘膜・病変を観察し、必要時に組織を採取して病理検査を行います。深さや由来の判断には、超音波内視鏡などの追加評価を検討します。

03 適切な病変は同時に処置

内視鏡治療に適したポリープは、十分な説明と同意のうえで同時切除・病理検査を行うことができます。大きな病変、特殊な部位、深部浸潤の疑い、薬剤や基礎疾患による高リスクがある場合は、段階的治療や外科評価が必要になることがあります。

04 病理結果とその後の管理

検査後の食事・活動、出血などの注意症状を説明します。病理、切除の完全性、既往歴から再検査計画を作成します。腫瘍や前がん病変が判明した場合は、該当する治療チームにつながります。

同時切除の可否は病変、前処置、薬剤、実施条件によります。予約時にポリープの既往と抗血栓薬の使用をお知らせください。

02 / 重点サービス

循環器の健康評価



診療場面のイメージ

循環器リスク、症状、既往疾患に応じた段階的な評価を行います。血圧、脂質、血糖、心臓の構造・リズム、心筋血流を確認し、必要時に循環器の専門検査・治療につなげます。

01 基本的なリスクと心機能

病歴に応じて、血圧、脂質・代謝検査、心電図、心エコー、ホルター心電図、自由行動下血圧測定などを選びます。冠動脈疾患、不整脈、弁膜症、心不全がある方は、病状と薬物治療も確認します。

02 心筋の血流と代謝

適応があれば、安静時または薬物負荷によるECT心筋血流検査を実施できます。PET/CTによる心筋代謝検査は、特定の臨床課題における代謝・心筋生存性の評価に用います。検査ごとに得られる情報が異なるため、医師が適切な方法を選びます。

03 冠動脈の精密検査

病歴、症状、既存結果から必要と判断した場合は冠動脈CT等を実施します。必要時には専門評価後に冠動脈造影を行い、薬物・カテーテル・外科治療を検討します。造影は侵襲的検査であり、全健診患者に通常実施する項目ではありません。

04 継続的なリスク管理

結果に基づいて血圧・脂質・血糖・体重の目標を設定し、服薬と運動を見直します。長期治療が必要な方には再検査・フォロー計画を作成します。胸痛、失神、強い息切れが出現した場合は速やかに受診してください。

ECT、PET/CT、冠動脈造影は病状と適応に応じて選択し、一律のスクリーニングとしては実施しません。

02 / 重点サービス

高齢者と複数疾患の総合管理



診療場面のイメージ

高齢者の総合診療と複数疾患の管理は、センターが長年取り組む重点サービスです。循環器、代謝、呼吸器、神経、腎臓などの疾患が併存する方では、疾病のコントロール、日常生活機能、栄養、本人の生活目標を総合的に考慮します。

01 全体評価と治療の優先順位

主要疾患、最近の変化、入院歴、睡眠・気分、認知機能、自立度を確認します。優先して治療すべき問題と経過観察できる問題を整理し、必要に応じて関連専門科が協議して段階的な診療計画を立てます。

02 複数の薬剤を一括して確認

複数の病院・診療科の処方を整理し、適応、用量、服薬時刻、重複、相互作用、肝腎機能の変化を確認します。低血圧、低血糖、出血、転倒のリスクに応じて個別の目標を調整し、服薬指導を行います。

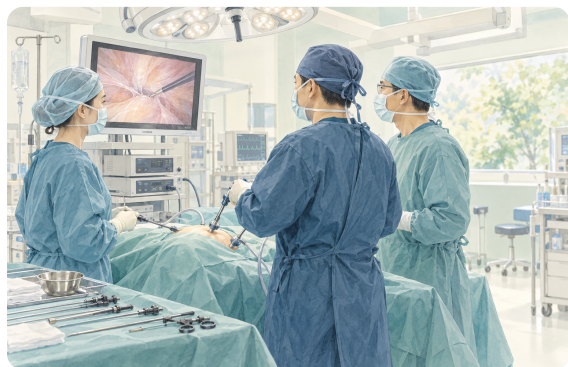
03 栄養と機能の維持

体重変化、食欲、嚥下、活動耐容能、筋力、転倒リスクを評価します。必要に応じて栄養支援、運動、リハビリ指導を行い、食事、移乗、歩行、生活上の援助を看護チームと確認します。

04 入院治療から長期ケアへ

集中的な検査、薬剤調整、短期観察が必要な場合は入院管理を検討します。退院前に本人と主な介護者へ疾病の要点、薬剤変更、再検査を説明します。長期フォローでは症状、機能、生活の質を確認し、病状に応じて管理を調整します。

臓器移植に関する診療



診療場面のイメージ

臓器移植は当院の重要な専門領域です。センターは総合評価とチームによる共同管理を通じ、末期臓器疾患の診療、移植専門評価、周術期治療、長期管理をつなぎます。移植申請の受け入れは一例ずつ審査します。

特色ある診療

臓器移植と継続的な疾病管理

対象となる疾患

- 末期肝疾患
- 末期腎疾患
- 心臓・肺などの末期臓器疾患
- 脾臓・小腸の移植関連ニーズ
- 多臓器疾患・移植後の問題

検査と評価

- 臓器機能と原疾患
- 感染・腫瘍・治療耐容性
- 移植専門科と受け入れ条件の審査

治療内容と方法

1 移植に関する診療

当院の移植医療は肝臓、腎臓、心臓、肺、脾臓、小腸、複合移植などの領域を含みます。具体的な治療方針は移植専門チームが個別に評価します。

2 原疾患治療と臓器補助

移植が不要、または現時点で不適切な患者には、原疾患治療、臓器機能補助、血液浄化、合併症管理を継続します。

3 周術期の共同管理

移植チームと専門評価、手術、長期治療を連携し、基礎疾患、栄養、リハビリ、日常ケアをセンターが管理します。

4 専門病棟と長期フォロー

手術と早期回復は専門病棟・移植監視病棟で行う場合があります。その後も臓器機能、感染、免疫抑制療法を監視します。

治療後の管理と留意点

移植は中国の法令、倫理規範、受け入れ管理要件に従います。海外患者は身元確認資料と完全な診療資料を事前に提出してください。受け入れ可否、時期、治療場所は審査が必要です。

膵島細胞移植と移植後の管理

膵島細胞移植と長期の移植後フォローは、移植医療における異なるサービスです。前者は糖尿病と関連条件の専門評価を要し、後者は移植臓器の機能、薬剤、感染リスク、日常の健康を管理します。

特色ある診療

膵島細胞移植



診療場面のイメージ

対象となる疾患

- 膵島細胞移植の評価を希望する糖尿病
- 移植後の臓器機能・薬剤の問題
- 移植後に併存する複数の慢性疾患

検査と評価

- 糖尿病の病型と膵島機能
- 血糖変動・低血糖歴
- 合併症と治療耐容性
- 移植歴・服薬記録

治療内容と方法

1 膵島細胞移植

当院は膵島細胞移植に関する診療を行っています。適応、技術的な方法、期待される利益、リスク、長期管理の要件を専門科が説明します。

2 血糖と合併症の管理

現在の薬剤、血糖記録、合併症から個別の方針を立てます。すべての糖尿病患者に適用される通常治療ではありません。

3 移植後の専門フォロー

移植の種類に応じて臓器機能、画像、感染検査、必要な薬物濃度測定を行います。機能異常があれば移植専門科につながります。

4 長期の総合管理

血圧、血糖、脂質、腎機能、骨、栄養も管理します。免疫抑制薬などの重要な薬剤は担当チームが調整します。

治療後の管理と留意点

各治療は中国の法令と関連要件に従います。完全な診療資料を事前に提出し、専門チームによる受け入れ条件・実施体制の確認を受けてください。

心臓の疾患



診療場面のイメージ

冠動脈疾患、不整脈、心不全、弁膜症、肺高血圧症に対し、薬物・カテーテル・外科治療から適切な方針を選びます。複数の慢性疾患がある方では、治療耐容性と回復に必要な支援も評価します。

特色ある診療

肺動脈除神経術（PADN）

専門的な適応評価・事前相談

対象となる疾患

- 冠動脈疾患・複雑冠動脈病変
- 不整脈
- 心不全
- 心臓弁膜症
- 一部の成人先天性心疾患
- 肺高血圧症と右心機能障害

検査と評価

- 心電図・心拍リズム監視
- 心エコー・血行動態評価
- 冠動脈造影、IVUS、OCT、FFR

治療内容と方法

1 冠動脈治療とバイパス術

バルーン拡張、ステント、適切な石灰化病変へのロータブレーター等を検討します。外科治療が必要な場合は、バイパス、低侵襲、ロボット支援、ハイブリッド治療を評価します。

2 アブレーションとペーシング

電気生理学的評価、高周波カテーテルアブレーション、恒久的ペースメーカー。条件を満たす場合は植込み型除細動器（ICD）、心臓再同期療法（CRT）も検討します。

3 弁膜症・構造的な心疾患の治療

弁形成・置換、適切な低侵襲・ロボット支援手術を評価します。一部の大動脈弁疾患ではTAVI/TAVR、先天性心疾患ではカテーテル閉鎖・手術を検討します。

4 肺高血圧症とPADNの専門評価

原因、心機能、血行動態を評価します。一部の適格患者では、肺動脈除神経術（PADN、高周波アブレーション）の適応をさらに検討します。病型、治療歴、実施条件に基づく判断が必要なため、事前にご相談ください。

5 薬物療法と心機能管理

心機能、体液量、基礎疾患に応じて、長期薬物療法、危険因子管理、心臓リハビリを計画します。

治療後の管理と留意点

治療後は抗血栓薬等、創部、合併症を確認し、心機能の再評価と活動再開を手配します。複雑な手術や術後の状態によっては監視病棟を使用します。

血管疾患と循環器リスク管理

大動脈、末梢動脈、静脈を対象に診療します。高血圧、脂質異常、循環器リスクは独立した管理対象とし、心臓・腎臓・代謝疾患の治療と連携します。

特色ある診療

カテーテル式腎交感神経除神経術（RDN）



診療場面のイメージ

対象となる疾患

- ・ 大動脈瘤・大動脈解離
- ・ 末梢動脈の狭窄・閉塞
- ・ 静脈瘤・静脈血栓症
- ・ 一部の肺塞栓症
- ・ 糖尿病足・難治性創傷
- ・ 高血圧・脂質異常症

検査と評価

- ・ 血管画像・血流評価
- ・ 血栓・出血リスク
- ・ 自由行動下血圧・心腎機能
- ・ 代謝・危険因子評価

治療内容と方法

1 大動脈・末梢動脈治療

大動脈ステントグラフト、バルーン拡張、ステント、一部のプラーク処置。病変に応じて開放手術、ハイブリッド、大動脈基部・弓部の複雑手術を評価します。

2 静脈・血栓の治療

静脈瘤には血管内レーザーや硬化療法などを検討します。血栓、静脈狭窄、一部の肺塞栓では、抗凝固、カテーテル血栓溶解、介入、フィルターを評価します。

3 血行再建と創傷修復

血流、神経障害、感染に応じて、適切な血行再建、局所処置、血糖管理、リハビリを行います。

4 高血圧へのRDN治療

適応を満たす高血圧患者には、腎動脈高周波アブレーションを含むカテーテル式腎交感神経除神経術（RDN）を実施できます。術前に血圧、薬剤歴、腎機能、腎動脈を評価し、術後も血圧監視、薬剤調整、長期管理を継続します。

治療後の管理と留意点

出血、血栓再発、創傷、活動能力をフォローし、血圧・脂質・代謝リスクを管理します。二次性高血圧が疑われる場合は原因を調べます。方法は血管解剖、病変、全身状態から決めます。

03 / 疾患別の診療

脳・神経系の疾患



診療場面のイメージ

脳血管疾患、脳・脊髄腫瘍、てんかん、運動・認知障害、末梢神経障害などを診療します。原因と病変に応じて、薬物、血管内治療、顕微鏡手術、リハビリを組み合わせます。

特色ある診療

大手術後の集中管理とリハビリ

対象となる疾患

- ・ 脳血管疾患・脳動脈瘤
- ・ 脳・頭蓋底・脊髄腫瘍
- ・ てんかん・パーキンソン病等
- ・ 三叉神経痛
- ・ 認知障害・頭痛・めまい
- ・ 末梢神経・睡眠関連の問題

検査と評価

- ・ 脳血管画像・灌流評価
- ・ ビデオ脳波・筋電図
- ・ 認知・神経機能評価
- ・ 必要な術中電気生理監視

治療内容と方法

1 脳血管内治療と手術

適格患者では動脈瘤の血管内治療・顕微鏡下クリッピング、頸動脈内膜剥離、頭蓋内外バイパスを評価します。脳卒中の原因と危険因子も管理します。

2 顕微鏡手術と神経内視鏡

脳・頭蓋底・脊髄腫瘍では、顕微鏡下切除、神経内視鏡、定位手術を検討します。複雑な頭蓋底病変は関連専門科が共同で対応します。

3 機能性疾患の治療

病状に応じて薬物、脳深部刺激、微小血管減圧等を評価し、症状の制御と神経機能の保護を両立させます。

4 神経リハビリと長期管理

運動、嚥下、言語、認知、日常生活能力に応じて治療後のリハビリを行い、慢性神経症状を継続評価します。

治療後の管理と留意点

大きな脳神経外科手術後は、院内共用ICUや専門監視病棟で特別な治療を要することがあります。急性脳卒中は直ちに救急対応が必要です。

03 / 疾患別の診療

消化器疾患と内視鏡治療

食道、胃、腸、一部の膵胆道疾患に対し、症状評価、内視鏡、病理、低侵襲治療を組み合わせます。外科手術やがんの集学的治療が必要な場合は、関連チームにつなぎます。

特色ある診療

EMR・ESD・ERCP・POEM



診療場面のイメージ

対象となる疾患

- ・逆流・腹痛・便通異常
- ・消化管出血・狭窄
- ・消化管ポリープ・早期腫瘍
- ・消化管粘膜下腫瘍
- ・食道アカラシア
- ・一部の膵胆道・小腸疾患

検査と評価

- ・胃・大腸内視鏡と病理
- ・超音波内視鏡
- ・適切な小腸カプセル内視鏡
- ・検体検査・画像・栄養評価

治療内容と方法

1 ポリープ・早期病変の切除

適切な病変では内視鏡的粘膜切除（EMR）、粘膜下層剥離（ESD）を評価します。粘膜下腫瘍では核出、トンネル法、全層切除等を検討します。

2 膵胆道内視鏡と処置

ERCPに関連する採石、ドレナージ、ステント、超音波内視鏡と適切な穿刺・ドレナージを行います。

3 機能性疾患・緊急内視鏡

アカラシアでは経口内視鏡的筋層切開（POEM）を検討します。病状に応じて内視鏡的止血、消化管狭窄へのステント等を行います。

4 消化器外科と総合治療

内視鏡に不適な腫瘍、消化器救急、その他の外科病変では腹腔鏡・開放手術を評価し、がん治療につなぎます。

治療後の管理と留意点

切除後は病理から完全切除と追加治療の必要性を判断し、食事、栄養回復、再検査を手配します。方法は病変の深さ、部位、リスクに応じて選択します。

03 / 疾患別の診療

肝胆膵疾患と複雑腹部手術



診療場面のイメージ

肝腫瘍、胆道・膵疾患、肝胆道結石、門脈圧亢進、脾臓関連の問題に対し、臓器機能、病変範囲、全身状態から方針を立てます。複雑な症例では手術、内視鏡、介入、全身療法を合わせて検討します。

特色ある診療

腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術（Whipple）

対象となる疾患

- 肝腫瘍
- 膵がん・膵頭部・乳頭部周辺病変
- 肝胆道結石・胆道疾患
- 膵炎と合併症
- 門脈圧亢進・脾臓関連疾患

検査と評価

- 肝予備能
- 3D画像計画・術中超音波
- 腫瘍範囲と血管との関係
- 栄養・感染・手術耐容性

治療内容と方法

1 腹腔鏡下Whipple手術

膵がん、および適応を満たす膵頭部・乳頭部周辺病変に対し、腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術を実施できます。腫瘍範囲と血管との関係から方針を判断します。

2 複雑肝切除と血管再建

適格患者では腹腔鏡や蛍光ナビゲーションを評価します。主要血管浸潤や腫瘍栓がある場合は、複雑切除・血管再建の実施可能性を検討します。

3 複数の内視鏡を用いる胆道治療

結石部位、胆道構造、手術歴に応じ、腹腔鏡、胆道鏡、消化管内視鏡または併用を選択します。膵炎では病状に応じたドレナージ・臓器補助を行います。

4 局所療法と全身療法

肝胆膵腫瘍では、アブレーション、介入、全身療法の順序を協議し、術後のがん治療につなげます。

治療後の管理と留意点

周術期は肝機能、血糖、栄養、感染、血栓リスクを管理します。大手術後の早期治療には院内共用ICUや専門集中治療病棟が必要な場合があります。

03 / 疾患別の診療

呼吸器・胸部の疾患

肺結節、肺がん、気道・胸膜疾患、慢性呼吸器疾患、睡眠時呼吸障害に対し、画像、肺機能、内視鏡採取、病理を踏まえ、観察、薬物、介入、手術を選びます。

治療と継続管理を一体に



診療場面のイメージ

対象となる疾患

- 肺結節・肺がん
- 気道狭窄・胸膜疾患
- 食道・縦隔腫瘍・胸腺疾患
- COPD・喘息
- 睡眠時呼吸障害

検査と評価

- 胸部画像・肺機能
- 気管支鏡・EBUS-TBNA
- 胸腔鏡・病理
- 呼気一酸化窒素・睡眠検査

治療内容と方法

1 胸腔鏡・ロボット支援手術

単孔式胸腔鏡、ロボット支援などの低侵襲技術を評価します。適切な中枢型肺がんでは、気管支・血管のスリーブ形成術を検討します。

2 気道介入と胸膜診療

気管支鏡生検、超音波気管支鏡下針生検を行います。狭窄にはバルーン拡張・ステントを評価し、胸膜病変には内科的胸腔鏡・生検を検討します。

3 食道・縦隔の外科治療

食道、縦隔、胸腺、一部の胸膜病変では、呼吸機能と栄養を考慮して胸腔鏡・その他の手術を評価します。

4 慢性疾患と睡眠の治療

薬剤・吸入器の指導を行い、睡眠検査に基づいて治療を評価します。夜間低酸素と循環器への影響にも配慮します。

治療後の管理と留意点

肺結節は画像変化とリスクに応じて経過観察、採取、手術を選びます。がん治療は病期と病理に基づき、治療後は呼吸リハビリと再評価につなげます。

03 / 疾患別の診療

腎臓・泌尿器の疾患



診療場面のイメージ

腎機能の保護、尿路の構造的異常、手術が必要な病変を総合的に評価します。急性・慢性腎疾患、尿路結石、泌尿器腫瘍、前立腺疾患、排尿障害などを診療します。

治療と継続管理を一体に

対象となる疾患

- 急性・慢性腎疾患と腎機能障害
- 尿路結石
- 腎・膀胱・前立腺腫瘍
- 前立腺肥大と排尿障害
- 女性の腹圧性尿失禁
- 男性の生殖関連の問題

検査と評価

- 腎機能・尿検査・画像
- 必要な腎生検
- 排尿機能・残尿評価
- 精液・生殖関連検査

治療内容と方法

1 血液浄化と腎疾患治療

血液透析、血液透析濾過、持続血液浄化、血漿交換、適切な免疫吸着を病状に応じて実施します。腹膜透析のカテーテル留置・管理も評価します。

2 泌尿器腫瘍の手術

腎・膀胱・前立腺腫瘍では、腫瘍制御と臓器機能を考慮し、ロボット支援、腹腔鏡、開放手術を評価します。

3 結石と排尿障害の治療

結石には軟性尿管鏡、経皮的腎碎石術を検討します。前立腺肥大には原因に応じた薬物・手術、腹圧性尿失禁には低侵襲スリング手術を評価します。

4 男性生殖の顕微鏡下技術

適切な患者では顕微鏡下精索静脈瘤手術、精巣内精子採取などを検討し、生殖医療チームと連携します。

治療後の管理と留意点

腎機能、感染、排尿状態を継続管理します。腎移植関連は10ページをご覧ください。術式は病変部位、病期、全身の耐容性から決定します。

03 / 疾患別の診療

骨・関節・脊椎の疾患

痛み、活動制限、構造的損傷に対して保存療法、低侵襲処置、手術の適応を評価します。心肺疾患、糖尿病、骨粗鬆症を伴う場合は、周術期リスク管理と機能回復も計画します。

治療と継続管理を一体に



診療場面のイメージ

対象となる疾患

- 重度の股・膝関節疾患
- 大腿骨頭壊死
- 肩・膝関節の損傷
- 頸腰椎椎間板・脊椎変性
- 骨折・手足の外科疾患
- 外反母趾

検査と評価

- 骨関節画像・機能評価
- 疼痛源・神経機能
- 骨の健康・周術期リスク

治療内容と方法

1 人工関節置換

病変と活動ニーズに応じ、股関節、膝関節、膝蓋大腿関節の置換を評価します。術前に機能目標とリハビリ計画を確認します。

2 関節鏡治療

肩・膝関節病変では関節鏡等を評価し、関節の安定性、術後保護、運動訓練を考慮します。

3 脊椎の低侵襲・固定術

神経機能、画像、疼痛源に応じ、顕微鏡支援、内視鏡、低侵襲固定術、その他の手術を評価します。

4 骨折・手足の外科

骨折と手足の疾患を評価・治療し、適格患者では外反母趾の低侵襲手術を検討します。

治療後の管理と留意点

高齢者では栄養、骨粗鬆症、内科基礎疾患も管理します。術後は創部、血栓、荷重、歩行訓練を確認します。手術の判断は画像だけでなく、症状と機能に基づきます。

03 / 疾患別の診療

内分泌・代謝の疾患



診療場面のイメージ

糖尿病、甲状腺、下垂体、副腎、骨代謝などを評価・治療します。検査結果と症状、薬剤、栄養、生活習慣を結び、長期管理の方針を立てます。

治療と継続管理を一体に

対象となる疾患

- ・ 糖尿病と合併症
- ・ 甲状腺機能異常・結節
- ・ 下垂体・副腎・副甲状腺疾患
- ・ 肥満・脂質・尿酸異常
- ・ 骨粗鬆症・骨代謝異常

検査と評価

- ・ 血糖変動・低血糖リスク
- ・ ホルモン・超音波・CT・MRI
- ・ 腎・眼底・神経・足の評価
- ・ 骨密度・二次性原因

治療内容と方法

1 血糖と合併症管理

現行治療、血糖変動、低血糖リスクから方針を調整します。感染、手術、急性疾患を伴う場合は適切な監視と治療を行います。

2 内分泌の専門治療

病型に応じて薬物療法を行います。手術、核医学治療、その他の専門治療が必要な場合は、関連チームと共同で方針を決めます。

3 体重と代謝の管理

食事、活動、睡眠、併存疾患、薬剤を考慮し、生活指導と適応のある薬物療法を行います。

4 骨の健康維持

薬物、栄養、運動を組み合わせます。骨折・活動障害がある場合は、整形外科、リハビリ、看護と連携します。

治療後の管理と留意点

病状の変化に応じて薬剤と目標を見直し、循環器・肝臓・腎臓リスクも確認します。膵島細胞移植には専門評価が必要です。11ページをご覧ください。

リウマチ・免疫性疾患

関節痛、発疹、反復する発熱、口・眼の乾燥、多臓器の障害には、体系的な免疫評価が必要な場合があります。疾患活動性を把握し、臓器保護、症状制御、長期治療リスクの低減を目指します。

治療と継続管理を一体に



診療場面のイメージ

対象となる疾患

- ・ 関節リウマチ・脊椎関節炎
- ・ 全身性エリテマトーデス・シェーグレン症候群
- ・ 全身性血管炎・炎症性筋疾患
- ・ IgG4関連疾患
- ・ 痛風・骨粗鬆症
- ・ 一部の自己免疫性肝疾患

検査と評価

- ・ 自己抗体・疾患活動性
- ・ 関節超音波・MRI等
- ・ 肺・心・腎・神経の障害評価

治療内容と方法

1 個別の薬物療法

病型、活動性、臓器障害、治療歴に応じて免疫調節薬等を選び、効果を継続評価します。

2 生物学的製剤と標的治療

条件を満たす場合は、生物学的製剤などの標的薬を評価し、感染リスクと反応から調整します。

3 複雑症例の専門技術

一部の症例では免疫吸着等を検討します。具体的な実施条件は関連する専門チームが判断します。

4 臓器保護と機能維持

障害臓器を関連専門科が共同管理し、関節保護、活動訓練、周術期の薬剤調整を行います。

治療後の管理と留意点

長期的に感染、血球、肝腎機能、骨、薬剤有害事象を監視します。診断は臨床像を総合して行い、単一の抗体結果だけでは判断しません。

女性の健康と生殖医療



診療場面のイメージ

成人女性の各ライフステージに応じ、婦人科疾患、子宮頸部病変、内分泌・更年期、骨盤底、生殖に関する評価を行います。他の系統の疾患がある方は、全身状態を考慮して診療を計画します。

治療と継続管理を一体に

対象となる疾患

- ・ 子宮・卵巣等の良性・悪性病変
- ・ 子宮頸部病変
- ・ 月経・卵巣機能異常
- ・ 更年期・骨盤底の問題
- ・ 不妊症
- ・ 妊娠・出産期の内科・外科合併症

検査と評価

- ・ 頸部HPV・細胞診・コルポスコピー
- ・ 必要な生検・ホルモン検査
- ・ 超音波等の画像
- ・ 双方の生殖評価・卵胞監視

治療内容と方法

1 婦人科の低侵襲手術

子宮鏡、腹腔鏡、3D腹腔鏡による診療を行います。婦人科がんは病理・病期に基づいて手術・全身療法を計画します。

2 頸部・更年期・骨盤底の治療

検査と全身状態から治療・フォローを決めます。妊孕性の温存を希望する場合は、可能性を事前に相談します。

3 生殖補助医療

当院では夫の精子を用いる人工授精、体外受精・胚移植、卵細胞質内精子注入、胚凍結に関する技術を実施しています。

4 妊娠・出産期の共同管理

高リスクや内科・外科合併症がある場合は、産科と管理場所を評価します。妊娠中の検査、分娩、特別な監視は産科の要件に従います。

治療後の管理と留意点

生殖補助医療は中国の法令と専門管理要件に従います。海外患者は受け入れ条件を事前にご相談ください。当センターは小児を受け入れていません。女性のデリケートゾーンの形成・修復は24ページをご覧ください。

眼・耳鼻咽喉・口腔の疾患

視力、聴力、呼吸、嚥下、日常の意思疎通に関わる疾患を診療します。局所病変とともに、糖尿病、抗血栓薬、その他の基礎疾患が手術と回復に及ぼす影響も考慮します。

特色ある診療

鼻機能改善手術と鼻内視鏡治療



診療場面のイメージ

対象となる疾患

- ・ 白内障・緑内障・眼底・角膜疾患
- ・ ドライアイ・涙道疾患
- ・ 慢性鼻炎・鼻甲介肥大・鼻中隔弯曲
- ・ 副鼻腔・一部の鼻頭蓋底病変
- ・ 聴力・めまい・睡眠呼吸・頭頸部疾患
- ・ 歯髄・歯周・顎顔面外傷・腫瘍

検査と評価

- ・ OCT・眼底造影・視野・超音波
- ・ 聴力・平衡・睡眠・内視鏡
- ・ 口腔・顎顔面の検査

治療内容と方法

1 眼科の手術と治療

小切開白内障超音波乳化・眼内レンズ、緑内障手術、角膜移植、硝子体手術・注射、網膜等のレーザー治療を行います。

2 耳鼻咽喉・鼻頭蓋底手術

耳の顕微鏡手術、鼻内視鏡、鼻頭蓋底手術を評価します。適格患者では髄液鼻漏修復、眼窩減圧、脳神経外科と共同で行う経鼻病変の治療を検討します。

3 鼻炎関連・鼻機能改善手術

慢性鼻炎、鼻甲介肥大、鼻中隔弯曲、副鼻腔疾患を、症状・鼻内視鏡・必要画像で評価します。標準的薬物治療後も症状が強く手術適応がある場合は、鼻甲介関連の機能改善手術、鼻中隔矯正、内視鏡下鼻副鼻腔手術を検討し、通気と機能を保護します。

4 口腔修復と外科

歯・歯髄、歯周、粘膜の治療、義歯、インプラント、矯正の評価を行います。顎顔面骨折、腫瘍、唾液腺病変には外科診療を検討します。

治療後の管理と留意点

基礎疾患がある場合は、処置条件、抗血栓薬、感染リスクを事前に評価します。術後は薬剤、食事、創部保護、再診を説明します。段階的修復や継続注射では、滞在期間と居住地でのフォローを事前に相談してください。

皮膚疾患と形成・再建



診療場面のイメージ

慢性皮膚疾患、瘢痕、難治性創傷、組織欠損、形成・美容上のニーズを対象とします。機能、外観、個人の希望、手術リスクを考慮し、プライバシーと十分な話し合いを重視します。

特色ある診療

顔面形成と女性のデリケートゾーンの形成

対象となる疾患

- ・ 湿疹・乾癬・白斑
- ・ 水疱性疾患・真菌症
- ・ 色素性・血管性病変・皮膚腫瘍
- ・ 熱傷後瘢痕・難治性創傷
- ・ 顔面形成・外観改善のニーズ
- ・ 女性のデリケートゾーンの形成・修復

検査と評価

- ・ 皮膚病理・免疫・真菌検査
- ・ 軟部組織・瘢痕・機能
- ・ 形成の目標と手術リスク

治療内容と方法

1 薬物・光線・レーザー治療

疾患に応じて薬剤、紫外線療法、適切なレーザー治療を選択します。

2 瘢痕と組織の修復

圧迫、薬物、瘢痕切除・拘縮解除、植皮、皮弁、組織拡張等を検討し、創傷治癒と運動機能を考慮します。

3 顔面の形成手術

顔の構造、皮膚・軟部組織、個人目標から方針を評価し、改善範囲、瘢痕、回復過程、リスクを説明します。

4 女性を中心とした外陰部形成

形態、快適性、修復のニーズに対し、出産歴、局所病変、骨盤底の状態から方針を立てます。必要時は婦人科、泌尿器科、骨盤底の専門家と連携します。

治療後の管理と留意点

プライバシーと十分な説明を重視します。結果は個人の条件、方法、回復過程によって異なり、具体的な方針は対面診察後に決定します。

03 / 疾患別の診療

乳腺・甲状腺とその他の外科疾患

乳腺、甲状腺、腹壁ヘルニア、肛門直腸の問題は、病変の性質と治療ニーズを明らかにしたうえで、基礎疾患に応じて観察、薬物、手術を選択します。

治療と継続管理を一体に



診療場面のイメージ

対象となる疾患

- 乳腺結節・腫瘍・腫瘍
- 甲状腺結節・外科治療が必要な疾患
- 鼠径・癒痕等の腹壁ヘルニア
- 肛門直腸疾患
- その他の腹部外科疾患

検査と評価

- 超音波・マンモグラフィ・採取
- 甲状腺機能・細胞診・組織診
- 欠損範囲・手術歴
- 肛門直腸の専門診察

治療内容と方法

1 乳腺手術と総合治療

病理、病期、全身状態に基づいて方針を立て、がん治療や形成再建につなげます。

2 甲状腺の外科治療

病変から切除範囲を決め、重要構造の保護と術後機能を考慮します。核医学・内分泌治療が必要な場合は共同評価します。

3 腹壁ヘルニア修復

部位、大きさ、再発、手術歴に応じて腹腔鏡または開放修復を選択します。

4 肛門直腸・その他の外科治療

血便、肛門周囲痛、便通異常の原因を確認して、保存的・手術的治療を相談します。消化器救急は病状に応じて対応します。

治療後の管理と留意点

術前に慢性咳嗽、排尿困難、栄養など回復に影響する因子を管理し、術後の活動と再診を説明します。強い急性痛や出血は速やかに受診してください。

03 / 疾患別の診療

がんの総合診療



診療場面のイメージ

病理診断、疾患範囲、全身状態の確認から治療を開始します。センターはがん・関連専門科と連携し、手術、全身療法、放射線、適切な局所治療をつなぐとともに、治療中の症状と基礎疾患を継続管理します。

特色ある診療

手術・薬物・放射線・局所治療

対象となる疾患

- ・ 肺・乳腺の悪性腫瘍
- ・ 消化管・肝胆膵の腫瘍
- ・ その他の固形がん
- ・ 再発・転移・複雑な治療ニーズ
- ・ 治療関連症状・栄養の問題

検査と評価

- ・ 病理相談・病期の再確認
- ・ 必要な追加採取・マーカー
- ・ 画像・既往治療効果・耐容性

治療内容と方法

1 全身薬物療法

病理型、承認適応、分子検査、臓器機能に応じて化学療法、分子標的、免疫療法を評価し、効果と有害事象を監視します。

2 高精度放射線治療

IMRT、VMAT、IGRT、SRS、SBRT、適切な術中照射などの技術を評価します。

3 手術と局所治療

病状に応じて手術、画像ガイド下アブレーション、介入、核医学治療をつなぎ、治療順序を総合的に検討します。

4 症状と生活の質

痛み、悪心、低栄養、感染等を管理し、必要に応じて心理支援とリハビリを行います。

治療後の管理と留意点

病期、治療反応、患者の目標を総合して方針を立てます。フォローでは効果、再発リスク、機能を確認します。一部の治療は専門病棟で行う必要があります。

血液疾患と細胞療法

貧血、血球減少、出血・凝固異常、白血病、リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成・骨髄増殖性疾患を診療します。病型、リスク、治療歴、全身状態に基づいて治療を計画します。

特色ある診療

CAR-Tと造血幹細胞移植



診療場面のイメージ

対象となる疾患

- ・ 貧血・血球減少
- ・ 出血・凝固異常
- ・ 白血病・リンパ腫
- ・ 多発性骨髄腫
- ・ 骨髄異形成・骨髄増殖性疾患

検査と評価

- ・ 血液・骨髄検査
- ・ 病型分類・リスク評価
- ・ 微小残存病変等の効果判定
- ・ 臓器機能・感染評価

治療内容と方法

1 全身療法と支持療法

病型とリスクに応じて薬物・支持療法を選び、感染、貧血、出血、臓器機能を管理します。

2 造血幹細胞移植

当院は自家・同種造血幹細胞移植に関する技術を有し、適切な適合・半合致移植を含みます。

3 CAR-T細胞療法

CAR-Tに関する診療を行っています。製品、適応、プログラムの性質、受け入れ条件、必要資料は、来院前に専門チームへ確認してください。

4 高齢者の血液疾患

複数疾患、栄養、活動能力、治療耐容性から治療強度、再検査、長期ケアを計画します。

治療後の管理と留意点

CAR-Tと造血幹細胞移植は中国の法令とプログラム要件に従います。一部の段階では専用移植室、層流病室、監視病棟での治療が必要です。事前にご相談ください。

リハビリテーションと疼痛管理



診療場面のイメージ

回復期から長期管理まで、リハビリと疼痛治療を行います。痛みの原因、活動能力、生活目標を踏まえ、薬物、訓練、理学療法、適応のある介入・低侵襲処置で機能改善を支援します。

治療と継続管理を一体に

対象となる疾患

- 脳卒中後・その他の神経機能障害
- 骨折・骨関節手術後の回復
- 熱傷修復後の機能障害
- 頸肩・腰下肢・脊椎関連痛
- 三叉神経痛・帯状疱疹後神経痛
- 一部の難治性疼痛

検査と評価

- 運動・日常生活・機能評価
- 疼痛源・神経徴候
- 画像・既往治療への反応

治療内容と方法

1 機能リハビリ

理学療法、作業療法、徒手・物理療法を行い、必要に応じて装具を使用し、専門科の再診と連携します。

2 疼痛への低侵襲技術

適応に応じて神経ブロック、高周波、脊椎内視鏡を評価します。骨粗鬆症性椎体骨折には椎体形成術を検討します。

3 難治性神経痛の治療

原因に応じて薬物、バルーン圧迫、高周波、脊髄刺激療法を評価し、機能、リスク、その後の管理を考慮します。

4 日常生活への復帰

安全な歩行、移乗、機能訓練、補助具の使用を説明し、院内訓練と在宅管理の目標をつなぎます。

治療後の管理と留意点

訓練強度は痛み、機能、耐容能に応じて調整します。長期臥床・重症回復期では栄養と皮膚にも配慮します。目標は日常生活のニーズに合わせます。

中医学による特色ある診療



弁証に基づく個別治療と継続管理

中医学（Traditional Chinese Medicine：TCM）は中国の伝統医学です。センターでは患者のニーズに応じて中医学的な弁証評価を手配し、既存の疾病管理、リハビリ、薬物療法と組み合わせます。

実施可能な中医学的方法

生薬・煎じ薬

中成薬

鍼灸

推拿

吸い玉

貼付療法

生薬による燻蒸

耳穴療法

個別評価と治療期間

中医師が問診・診察から症状、体質、生活習慣、経過を把握し、現代医学の診断・検査も踏まえて方針を立てます。長期管理では症状、食事、睡眠、活動の変化をフォローします。

現在の治療との連携

適切な慢性症状、疼痛、回復ニーズに中医学的方法を検討します。中医薬を含むすべての薬剤、アレルギー、抗凝固療法をお知らせください。相互作用、肝腎機能に配慮し、処方と再診計画を明確にします。

感染症と原因不明の発熱



診療場面のイメージ

反復する発熱、複雑な感染、免疫機能が低下した患者の感染は、経過、接触歴、治療歴、検査から原因を調べます。センターは感染症・関連専門科の評価と、必要な隔離・紹介を手配します。

治療と継続管理を一体に

対象となる疾患

- 原因不明・反復する発熱
- 複雑感染・耐性菌感染
- 真菌感染・重症感染
- 移植・血液疾患・免疫抑制患者の感染

検査と評価

- 旅行・接触・服薬歴
- 微生物培養・分子検査
- 感染部位・薬剤感受性・臓器機能
- 画像・非感染性原因の評価

治療内容と方法

1 原因に応じた治療

病原体、感受性、感染部位、抗菌薬使用歴に基づいて、的を絞った治療を計画します。

2 複雑な患者の共同管理

免疫機能低下や複数疾患がある場合は、感染症・関連専門科が共同評価し、相互作用と臓器機能を確認します。

3 局所処置と臓器補助

病状に応じてドレナージ等の局所処置を検討し、重症患者は速やかに監視・臓器補助につなぎます。

4 隔離と転院

特殊な感染症や伝染性疾患では隔離治療が必要です。センター入院後でも、病原体、隔離条件、治療上の必要性から、専門の感染症病院へ転院する場合があります。

治療後の管理と留意点

予約時に最近の発熱、接触歴、既知の伝染性疾患、耐性菌結果を正確にお知らせください。呼吸困難、低血圧、意識変化がある場合は速やかに救急受診してください。

大手術と重症患者への支援



診療場面のイメージ

複雑な手術と重症治療には、外科、麻酔、集中管理、関連専門科が共同で参加します。センターは病状に応じて治療場所とケア資源を調整し、安定後はリハビリ、基礎疾患管理、退院準備を継続します。

01 周術期の評価

心肺・肝腎機能、栄養、感染、血栓・出血リスクを総合評価し、麻酔と監視の必要性を確認します。抗血栓薬、血糖降下薬、免疫抑制薬等の長期使用者では、専門科の意見を踏まえて周術期の薬剤計画を作成します。

02 臓器補助と集中治療

当院では病状に応じ、人工呼吸、持続血液浄化、血漿交換、関連する人工肝補助を行います。適応があればECMO等を評価します。血行動態、超音波、検体検査を活用し、栄養、感染、早期リハビリにも配慮します。

03 共用ICUと専門病棟

大きな脳神経・心胸部・腹部手術、その他の重症状態では、院内共用ICU、移植監視、専門病棟が必要な場合があります。病床と治療場所は病状・監視条件から決まり、復帰基準を満たした後にセンターで治療とケアを継続します。

04 急変と遠方からの転院

院内急変時には必要な救急治療・専門相談を開始します。他地域・海外からの転院希望者は、最近の病状、生命維持、薬剤の資料を事前に提出してください。受け入れチームが可能性を評価し、搬送の時期・方法は担当医療チームが共同で判断します。

高度画像検査と機能評価



診療場面のイメージ

構造をみる 機能を理解する

具体的な臨床上の課題に応じ、適切な検査を選択します。

CT / MRI

構造・疾患別画像

CT、造影・血管画像、高磁場3.0T MRIと疾患別シーケンス。必要に応じて血管壁、マルチパラメトリック、動態・機能画像を評価します。

超音波

形態・血流・動態

心臓、腹部、甲状腺、乳腺、泌尿器等を評価します。造影、エラストグラフィ、フュージョン画像を組み合わせ、移植前・術中・術後の監視も支援します。

PET/CT

代謝と総合評価

適応に基づくがん評価、心筋代謝・脳代謝画像により、機能情報と解剖画像を統合します。

ECT / SPECT

灌流と臓器機能

SPECT/CT関連の心筋・脳血流、骨・腎・甲状腺等のシンチグラフィ。臨床上の課題とトレーサーの条件から項目を選択します。

マンモグラフィ、骨密度、必要なX線検査等もあります。予約時に妊娠の可能性、植込み機器、金属異物、造影剤への反応歴をお知らせください。

画像ガイド下処置と精密診断



診療場面のイメージ

位置の特定・検体採取から病理判断・分子検査まで、治療方針の根拠となる情報を提供します。

01

画像ガイド下の処置

超音波・CTガイド下の針生検、吸引、カテーテルドレナージ、適切なアブレーションを行います。超音波では造影・フュージョン画像も使い、高周波・マイクロ波等を病状に応じて評価します。

02

病理と細胞診

組織病理、細胞診、術中迅速凍結診、特殊染色、免疫組織化学、免疫蛍光、in situハイブリダイゼーション。難しい症例では病理コンサルテーションを手配できます。

03

遺伝子・薬剤関連検査

明確な適応に基づき、腫瘍分子、特定疾患、個別薬物療法の遺伝子検査を評価します。薬物濃度・代謝検査は、一部の免疫抑制薬などの使用を支援します。

04

結果の統合と次の対応

血液、生化学、免疫、内分泌、微生物検査を臨床的に解釈します。センターは重要な結果を現在の治療につなげ、未判明結果の連絡方法も明確にします。

病理スライド、パラフィンブロック、元の画像データ、遺伝子報告書の提出方法は、事前にご相談ください。

看護・生活支援と言語サービス



診療場面のイメージ

常設の医師・看護チームが、日常診療、状態観察、薬剤確認、健康教育に参加します。活動能力、病状、意思疎通のニーズに応じてケアと付き添いを手配します。

01 検査への付き添い

検査区域へは通常スタッフが付き添います。病状が安定し、自力で移動できる患者には一般スタッフが対応します。病状・移動制限から専門的観察やケアが必要な場合は、評価後に看護師等の医療職が付き添います。

02 中国語・英語のサービス

通常は中国語と英語に対応します。その他の言語は希望と利用可能な資源に応じて調整し、患者自身の通訳同行も可能です。いずれも用意できない場合は翻訳ソフトを主な補助手段とします。重要な病歴、薬剤、治療判断は双方の理解を確認します。

03 看護と生活援助

治療支援、服薬指導、活動援助、栄養・皮膚の観察、転倒等のリスク評価を行います。生活援助の範囲は病状と自立度に応じます。付き添い、食事、その他の特別な希望は予約・入院時にお知らせください。

04 プライバシーと医療資料

説明に参加する家族・代理連絡者の希望をお伝えください。許可なく他の患者、医療職、診療行為を撮影・録音・録画しないでください。資料は通常、中国語・英語で提供できます。他言語は対象資料、提供方法、準備期間を事前にご相談ください。

受診申請から退院後のフォローまで

電話、メール、WeChatでセンターに直接ご相談いただけます。完全な資料を事前に提出すると、適切な診療方針、追加検査、来院前の準備を判断しやすくなります。

01

来院前に申請

中英併記の国際患者受診申請書に、症状、既存診断、解決したい問題、来院予定を記入し、病歴、画像、病理、薬剤一覧を提出します。言語、移動支援、付き添い等の希望もお知らせください。すべての専門科を自分で決める必要はありません。

02

評価後に受診を確定

資料を確認し、必要時に追加情報を求め、専門評価を行います。受け入れ範囲を確認後、外来・入院を相談します。民間保険を利用する方は事前に情報を提出し、補償範囲、承認、直接精算条件を確認してください。センターは保険商品の販売は行いません。

03

来院後の診療と相談

外来は水西院区2階・第1診療区域、入院は16階A/B区です。対面診察と追加検査から方針を整え、必要時に予定を変更します。入院証と職員の案内に従って手続きし、身分証、元の診療資料、現在の薬剤情報を持参してください。

04

退院資料とフォロー

退院時に診療資料、薬剤、再検査と、未判明結果の連絡方法を確認します。短期は主に電話、長期はメール・WeChatを用い、頻度は病状に応じます。急性症状や明らかな悪化は所在地で速やかに受診し、その後センターと継続管理を相談してください。

短期：電話 | 長期：メール・WeChat | 頻度：病状に応じて調整

入院環境と日常のケア

水西院区16階A/B区・専用病室・個室とスイート



一部スイートの応接スペース。実際の部屋と設備は手配内容によります。

独立した空間

専用トイレ・シャワー、ベッドサイド呼出、基本的な生活設備を備えます。一部のスイートには応接・付き添いスペースがあります。病状と空床状況に応じて部屋を選びます。

付き添いと生活

付き添いや臨時ベッドが必要な場合は事前にお知らせください。病衣・寝具を提供します。清掃・設備修理は職員にご相談ください。

食事と看護

治療食、特別食、宗教上の食事は事前にご相談ください。病状に応じて服薬指導、活動支援、栄養・皮膚観察を行います。

治療場所の変更

隔離、専用移植室、集中治療が必要な場合は、適切な治療場所を使用します。安定後にセンターへの復帰を評価します。

生活用品、付き添い、設備の詳細は、入院ガイドと病室設備資料をご覧ください。

受診相談と資料の入手

受診予約・総合相談

+86-022-23628221

平日 8:00-12:00 / 14:00-17:00

TFCH_interclinic@hotmail.com

メールは通常48時間以内に返信します。

週末・法定祝日

外来は休診

連絡先：+86-022-23626360

緊急時は救急外来を受診するか、所在地の救急サービスへご連絡ください。

水西院区

中国・天津市西青区西営門街保山西道2号

外来：2階・第1診療区域

入院：16階A/B区

国際診療センター相談用WeChat



読み取ってご相談ください

受診相談・フォロー・ご意見

QRコードからセンターへ、予約、病状の相談、フォロー、ご意見をお送りいただけます。受診申請書、外来ガイド、入院ガイド、病室設備資料も入手できます。

初回は主な病状、希望する診療サービス、連絡先を簡潔にお知らせください。